Diskussion 639

Datum: 1930-06-03
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 3
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: [1] kvinna-ord, [2] släktskaps- och tilltalsord, [3] yrkestitlar.

1. Israel Holmgren (Frisinnade folkpartiet, man)

Herr talman! Eftersom det här av den förste talaren framhölls, att det drivits en intensiv agitation inom riksdagens kamrar i denna sak, ber jag till en början att få framhålla, att jag för min del har avhållit mig från varje slag av propaganda inom riksdagen i den här saken.

Det har av föregående talare framhållits mycket kraftigt, att det nu föreliggande förslaget avser att förverkliga enhetstanken, tanken på ett sammanförande av alla Karolinska institutets kliniker och övriga institutioner till en helhet, till en enhet. Den tanken — det ber jag att få fästa uppmärksamheten på, eftersom ingen har gjort det förut här i dag — förverkligas emellertid i mycket ringa mån genom det nu framlagda förslaget. Det är nämligen så, om man ser på vad som är föreslaget, att av de fem kliniker, som man kan säga flyttas till det nu projekterade sjukhuset, är det bara tre, om vilka man kan säga, att deras förflyttning medför en realisation av enhetstanken, under det att de två andra redan förut ligga vid det nuvarande Serafimerlasarettet, således i anslutning till Karolinska institutets övriga där förlagda kliniker. I stället är det garnisonssjukhuset, vanföreanstalten och radiumhemmet, vilka 1 mindre grad ha att göra med den medicinska högskolan, som nu skulle sammanföras till detta Karolinska sjukhus. Till den andra etappen kvarstå i själ-

va verket ytterligare tio av Karolinska institutets kliniker. Jag anför detta såsom en brist hos förslaget, därför att jag själv är vän av enhetstanken.

Det har sagts i dag, att de teoretiska institutionernas företrädare äro enhälligt för denna enhetstanke, men det är verkligen knappast förhållandet, fastän det kan se ut så i papperen. Jag nämner detta därför, att utskottet på sidan 37 i utlåtandet säger: »Då de, som vid institutet bära ansvaret för den teoretiska utbildningen, samfällt förordat frågans lösning på föreslaget sätt, måste det förutsättas, att de också gjort klart för sig, att de teoretiska institutionerna tills vidare kunna hjälpa sig fram utan omfattande nybyggnader.» Jag ber att få framhålla, att jag för min del icke är säker på, att de teoretiska professorerna se saken så, utan de anse nog att, om icke den tredje etappen med de teoretiska institutionerna kommer snart, nybyggnader bliva alldeles oundgängliga och ganska omfattande sådana på den plats, där institutionerna nu ligga.

När denna fråga var före vid 1926 års riksdag beslöts det en förnyad skyndsam utredning, därvid i främsta rummet skulle beaktas synpunkten att söka nedbringa kostnaderna till skäliga proportioner. Den dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet framhöll detsamma i den kungl. propositionen och att denna förnyade utredning borde ske med aktgivande å den i ärendet förebragta kritiken.

Om man ser på det förslag, som nu framlagts, så kan man icke säga, att det tager hänsyn till riksdagens uttalande och icke heller till statsrådets uttalande om aktgivande på den i ärendet förebragta kritiken. Ty det förslag, som nu framlagts, är i själva verket i huvudsak samma förslag, som år 1926 kom under riksdagens prövning. Om man jämför ritningarna, kan man se, att det i huvudsak är detsamma. Naturligtvis har man måst vidtaga en hel del ändringar och tillägg på grund av att vanföreanstalten och den radioterapeutiska kliniken m. m. tillkommit, men i huvudsak är förslaget detsamma, och jag måste alltså i huvudsak mot detta förslag framföra samma anmärkningar som jag framställde gentemot 1926 års förslag. Man kunde veta på förhand, att detta förslag skulle bli detsamma, som det som framlades år 1926, så snart man fann vilka sakkunniga sjukhuskommissionen tillkallat och vilken arkitekt den hade tillkallat. Det var samma arkitekt, och de sakkunniga voro de, som voro särskilt starkt bundna att icke göra några ändringar i det förra förslaget. Därav har följden blivit, att man fått ett förslag, som icke i någon synnerlig grad realiserar riksdagens förut uttalade önskemål. De anmärkningar som jag framställde då och som jag nu i min motion framställt mot förslaget äro dels att det mycket väl, utan att ändamålsenligheten behövt tillbakasättas, kunde gjorts betydligt billigare — man hade säkert kunnat spara några miljoner för statsverket — och dels att man kunnat göra förslaget ändamålsenligare i en hel del viktiga avseenden, som det nu icke kan falla mig in att närmare gå in på. Anledningarna till dessa enligt min mening betydande bristfälligheter i förslaget ligga däruti till väsentlig del, att de som utarbetat förslaget icke tagit tillbörlig hänsyn till de moderna strömningar inom sjukhusbyggnadskonsten som för närvarande göra sig gällande och vilket kunnat medföra ett betydligt förbilligande av kostnaderna. Skall detta sjukhus byggas enligt det föreliggande förslaget kommer det därför att redan vid sin invigning vara ett föråldrat sjukhus i viktiga avseenden. Jag hyser en stor beundran för den arkitekt som uppgjort förslaget, jag beundrar honom såsom en frarnstående konstnär och såsom en fin kulturpersonlighet. Han har byggt en stor mängd sjukhus förut, men jag anser, att man i en så viktig sak som denna är, måste säga vad man tycker. Jag anser — hur tråkigt det än är att behöva säga det — att han icke är så inne i de moderna strävandena beträffande sjukhusbyggnadskonsten att han

varit uppdraget vuxen. Det är icke endast kvantitativa, utan även kvalitativa olikheter av betydande vikt att taga hänsyn till vid denna sjukhusbyggnad i jämförelse med andra sjukhus i vårt land.

Således menar jag, att resultatet av denna »omarbetning» av 1926 års förslag var på förhand givet och att det finnes många brister i det föreliggande förslaget. Detta har utskottet liksom

även reservanterna erkänt, och utskottet anser, att det av detta skäl är nödvändigt att överarbeta förslaget för att få kostnaderna väsentligt nedsatta, såsom utskottet säger i motiveringen, och avsevärt nedsatta, såsom utskottet säger i sitt yrkande, och att samtidigt om möjligt få ett ändamålsenligare förslag, där det kan befinnas vara önskvärt.

Jag är mycket tacksam mot utskottet för att det tagit denna hänsyn till den motion, som jag har framlagt. Emellertid, när man läser utskottets motivering närmare, börjar man på att bli betänksam och att undra, om utskottet verkligen menar allvar med den överarbetning av förslaget till åstadkommande av en betydande nedsättning av kostnaderna som -: utskottet föreslår. Den betänksamheten uppstår, när man läser på sidan 37 i utskottets utlåtande, nedersta stycket, där det står på följande sätt: »Utskottet kan visserligen icke i allo dela de av herr Holmgren framförda synpunkterna — sålunda synes utskottet den av honom mot den radioterapeutiska kliniken riktade kritiken icke befogad, om hänsyn tages till utvecklingen på detta område av medicinen och nödvändigheten att planera denna del av sjukhusanläggningen så. att den motsvarar behovet för en avsevärd tid framåt.»

När man läser detta, undrar man, om utskottet icke blandat ihop den röntgendiagnostiska avdelningen och den radioterapeutiska kliniken. Det är framför allt i fråga om den röntgendiagnostiska avdelningen vid sjukhuset som jag uttalat mig om den överdrivna storleken. Den är tilltagen i sådana proportioner, att man icke kan anse dem vara skäliga. Den är 16 gånger så stor som motsvarande utrymme vid det nuvarande Serafimerlasarettet är. Jag är glad över, att utskottet icke undantagit denna avdelning från den blivande utredningen. Vad jag har sagt i fråga om den radioterapeutiska kliniken baserar sig mera på andra saker. Den radioterapeutiska kliniken innehåller vårdavdelningar, vilka äro konstruerade på samma sätt som sjukhusets övriga avdelningar. Det är då ganska egendomligt, att man, om man avser att granska och överarbeta planen till sjukhusets vårdavdelningar, om man avser att nedbringa kostnaden avsevärt, undantager från granskningen de vårdavdelningar, som äro belägna inom den radioterapeutiska kliniken. Det är mycket svårt, tycks det mig, att finna skälen därtill.

I min kritik av den radioterapeutiska kliniken har jag därjämte talat om organisationen. Det vidrör utskottet icke. Jag har framhållit, att ett skäl till att denna klinik blir onödigt dyr är, att den skulle organiseras på det sätt, att det skulle bli autonomi för denna klinik i större utsträckning än som är nödvändigt, med därav följande ökad personal, ökade utrymmen och så vidare. Professor Gösta Forssell har i en artikel i Socialmedicinsk tidskrift, som utkommit för några dagar sedan och som jag förmodar att en stor del av kammarens ledamöter har läst, bemött denna min kritik av den radioterapeutiska klinikens organisation. Jag skall icke ingå i några detaljer, utan jag skall endast påpeka, att den utförliga framställning, som finnes där och som säkerligen är sakligt fullkomligt riktig, dock icke tager bort udden av den kritik, som Jag riktat mot den ifrågavarande organisationen. Jag ber bara att få taga ett exempel. Där framhålles på en hel spalt vilket oerhört stort arbete som skulle komma att påvila den sociala kurator, som man tänkt skulle anställas vid den radioterapeutiska kliniken. Det är alldeles

riktigt. Kuratorn skulle säkerli-

gen komma att få ett omfattande och mycket betydelsefullt arbete, men jag har aldrig anmärkt på att denne kurator skulle anställas, utan jag har anmärkt på, att man skulle anställa en social kurator enkom för den radioterapeutiska kliniken. Jag har tänkt mig, att det vore billigare och riktigare att denna del av klinikens verksamhet tillsammans med alla de andra klinikernas verksamhet av samma art vore centraliserad på ett ställe inom sjukhuset. Jag nämner detta bara i förbigående för att visa huru liten saklig betydelse Forssells försvar har.

Jag kan således icke anse annat än, att det är oberättigat och olämpligt, och det har förvånat mig, att utskottet velat helt och hållet undantaga den radioterapeutiska kliniken från den granskning ur ekonomiska synpunkter, som sjukhuset i övrigt skulle undergå. Jag säger rent ut, att man måste komma till den uppfattningen, att det är professor Gösta Forssells imponerande personlighet, hans övertalningsförmåga och tjusningskraft som här gjort sig gällande, men icke så mycket några motsvarande sakskäl. För min del är jag fullständigt övertygad att, om icke detta förslag till den radioterepeutiska kliniken och till den röntgendiagnostiska avdelningen haft en så utomordentlig förespråkare som professor Forssell med hans berömda namn och hans personliga tjusningsförmåga skulle ingen människa ha reflekterat på att taga ett så oerhört stort och vidlyftigt förslag. Detta är min bestämda övertygelse, och jag anser det också vara min plikt att uttala det vid detta tillfälle.

Utskottet säger, att man med god vilja skall kunna väsentligt nedbringa kostnadssumman. Ser man emellertid på att utskottet från denna granskning vill undantaga den del, som uppenbarligen framför allt annat är i behov av granskning, så tycker man, att det icke just visats något god vilja från utskottets sida. Jag frågar, vem som skall göra denna granskning av det föreliggande förslaget, som utskottet yrkar på? Skall det vara samma personer som gjort upp förslaget? Då blir hela den nya granskningen endast en fars, ty det blir precis samma resultat, och det kommer icke att vidtagas någon nämnvärd ändring 1 1926 års förslag. Tänker man att jag skulle medverka till en sådan granskning? Det kan jag inte göra, det vill jag icke åtaga mig, en granskning så begränsad som utskottet här förutsatt.

Jag övergår nu till frågan om garnisonssjukhuset, som här åtskilligt varit på tal. Jag måste säga, att jag tycker, att general Hammarsköld har rätt uti, att det vore önskligt, att denna fråga hölles svävande, när man vill gå in för en ny förhandling med Stockholms stad om ett ökat antal platser. Han redogjorde för anledningarna till att detta måste anses vara viktigt, och jag kan icke finna annat än att han har rätt i detta. Dessutom skulle jag vilja säga, att även om man vill gå in för att garnisonens sjuka skola vårdas å det karolinska sjukhuset, det icke därför är nödvändigt, att man tycker att det sätt som här föreslås skulle vara det bästa. Jag kan icke förstå, varför man icke, om förslaget ändå skall granskas under ett år, skulle ha tillfälle att tänka på andra sätt för ordnande av vården av garnisonens sjuka å det karolinska sjukhuset än Just det sätt som här är föreslaget. Detta sätt har nämligen, herr: talman, mött

ganska mycket motstånd från Karolinska institutets sida, såsom herr Hammarskjöld för en stund sedan genom citat ur tillgängliga handlingar har belyst. Det har varit med den största tveksamhet, som man givit med sig inom Karolinska institutet. Det är tydligt, att det för ett universitetssjukhus måste vara ganska besynnerligt och olämpligt att i sin mitt ha en avdelning med militär organisation som skall ha manliga sjukvårdare — under det att de andra sjuka å hela sjukhuset för övrigt, såsom övriga sjukhus skola ha **kvinnliga**[1] sj 1 i tillsättes av universitetsmyndigheterna, liksom alla andra läkare, utan han

skall tillsättas av arméns sjukvårdsstyrelse. Den biträdande överläkaren är närmaste man under professorn, och det är icke alls underligt att man känner sig mycket betänksam inför någonting sådant.

Vidare har generalfältläkaren rättighet att deltaga i sjukhusdirektionens alla sammanträden, och han har rösträtt i alla frågor, som ha något att göra med de sjuka, som vårdas där från garnisonen. Det där är många omständigheter som jag liksom mina kolleger inom institutet måste finna vara ganska otrevliga och innebära möjlighet till slitningar och konsekvenser, som icke äro så lätta att överblicka.

Vad sedan angår sjukmaterialet på garnisonssjukhuset, som det talats om här i dag, har det anförts, hurusom Karolinska institutets lärare framhållit, att det kan gå för sig, men att det icke är av samma värde för undervisningen som det övriga sjukhusmaterialet. Generalfältläkare Bauer har för att belysa det nuvarande materialets värde för undervisningen gjort upp en tablå, som jag har här i min hand. Om man ser på den tablån, så finner man av siffrorna, att de sjukdomar som förekommit mest bland dem som skulle ha värde för undervisningen äro t. ex. halsfluss och tuberkulos i olika former. Jag ser för sista året siffran 129 för halsfluss och siffran 91 för fall av tuberkulos. Det är alldeles riktigt, som generalfältläkaren säger, att sådana sjukdomsfall äro av betydelse för undervisningen. Men man frågar sig: kan det vara riktigt, att dessa smittosamma sjukdomsfall skola läggas in på garnisonsavdelningen liksom andra sjuka? Skulle det icke vara mycket bättre och riktigare, om dessa smittosamma sjuka intoges på sjukhusavdelningar särskilt avsedda för den sjukdom de ha, att de tuberkulöst sjuka vårdades tillsammans med sjukhusets övriga tuberkulospatienter och att halsflusspatienterna vårdades på sjukhusets infektionsavdelning? Det lider inte minsta tvivel att ur modern sjukvårdssynpunkt skulle det vara lämpligare. Det innebär naturligtvis en risk för sjukhuset, om sådana sjuka vårdas där utan vederbörlig hänsyn tagen till sin smittande karaktär. Det kan man visserligen ta hänsyn till i en viss grad också på garnisonsavdelningen, men det blir naturligtvis icke lika praktiskt som om man sammanför dem på en avdelning särskilt avsedd för ändamålet. Och när det är så, att just själva avsikten med att inkorporera garnisonssjukhuset med det stora nya kliniska sjukhuset är att därigenom tillförsäkra de värnpliktiga den bästa möjliga vård — det är en så vacker tanke, denna generalfältläkare Bauers tanke, att de värnpliktiga skola få den bästa möjliga sjukhusvård, att de skola vårdas på ett sjukhus, utrustat med alla modärna resurser och där det finnes alla slags specialister som kunna ägna de värnpliktiga den mest förstklassiga vård

— frågar man sig, varför kan icke den tanken nås på annat sätt än på detta sätt med en särskild militäriskt ordnad garnisonsavdelning? Om man tänker på sjukvården, kan ett gott resultat nås mycket bättre, om man lägger in dem som vanliga dödliga människor på sjukhuset, utan att göra någon särskild avdelning; då skulle man vara av med alla obehag på en gång. Jag vill citera ett yttrande, som hans excellens herr statsministern för en stund sedan fällde, då han hemställde, om de militära sjuklingarna icke skulle bli lika bra eller bättre tillgodosedda, om de inlades på ett vanligt sjukhus än om de skulle inläggas på ett militärt sjukhus. Jo, det är just vad de kunna bli, och de kunna också bli bättre vårdade, om de icke vårdas under den form, som här föreslås, utan de vårdas på sjukhuset precis som andra, utan att sammanföras till särskilda garnisonsavdelningar med sämre sjukvårdsförhållanden. Om man icke gör det, skulle man kunna giva dem en förstklassig vård.

Således, herr talman, jag finner att utskottets yrkande lider av vissa fel, och jag önskar framställa ett par särskilda yrkanden. Först vill jag då förena

mig i det yrkande, som framställts av herr Hammarskjöld, att punkten 12 i utskottets yrkande skulle utgå, således den punkt som rör garnisonssjukhuset. Vidare yrkar jag, att ur utskottets motivering på sidan 37 nedersta stycket skall utgå den passus — som jag nyss läste upp och som vill förhindra den blivande utredningen att sysselsätta sig med den radioterapeutiska kliniken — som börjar med ordet »sålunda» och slutar med ordet »framåt». Jag föreslår, att första delen av nämnda stycke i stället skall få följande lydelse: »Utskottet kan visserligen icke i allo dela de av herr Holmgren framförda synpunkterna, men åtskilligt av vad i herr Holmgrens motion anförts torde vara värt beaktande», varefter det skulle fortsätta på samma sätt som utskottet gjort.

Till sist vill jag, herr talman, säga, att jag i valet mellan utskottets förslag oförändrat och reservationen kommer att rösta för den senare, då jag anser att ingenting är att förlora, men mycket att vinna genom att en rejäl och allvarlig överarbetning av förslaget kommer till stånd.

2. Värner Ryden (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Det ärende, som här föreligger, har varit nästan ett av de besvärligaste som jag varit med om att behandla, ur den synpunkten, att det varit så ytterligt svårt för en lekman att komma till en bestämd uppfattning och övertygelse. Här har stått emot varandra de yppersta män inom den svenska läkarvetenskapen, personer, som man vill tro, när man hör den ene tala för sin sak, och också när man hör den andre tala för sin motsatta uppfattning. Till slut har man måst ställa sig på det sättet, att man måst söka arbeta sig fram till en uppfattning oberoende av de auktoriteter, som i detta avseende stått bestämt mot varandra.

Hans excellens herr statsministern sökte att, såsom skäl för att man borde taga utskottets förslag, anföra att man därmed endast fattade ett principbeslut och icke bunde sig för framtiden. Detta uttalande är fullständigt oriktigt. Jag framlade i statsutskottet vid detta ärendes behandling ett förslag, som jag tänkte mig, att man skulle vilja vara med om, och detta förslag gick ut på, att man bara skulle fatta ett principbeslut och icke gå längre i år. Jag

vill skissera hurudant förslaget var. Jag föreslog, att man skulle gå på den linjen, att man definitivt accepterade enhetstanken, således sammanförande av de teoretiska och kliniska institutionerna, och att man skulle fatta ett bestämt beslut i den principfrågan. Vidare att man definitivt skulle bestämma sig för Norrbackaområdet såsom varande den enda tomt, som vore så stor, att man med säkerhet å densamma kunde förverkliga enhetstanken, och att man i övrigt skulle uppskjuta avgörandet av byggnadsfrågan till ett kommande år. Jag föreslog, att man skulle undersöka ett alternativ, som kommit fram vid slutet av utskottets handläggning av ärendet och som föreföll mig vara av mycken stor betydelse. Det är den tanke, som finnes i reservationen, att man skulle förhandla med Stockholms stad om att kronan och staden skulle tillsammans skapa ett stort kommunalt sjukhus i Norrbacka, ett sjukhus, som genom sin storlek och sin karaktär av kommunalt sjukhus skulle kunna tillförsäkra ett klientel åt den medicinska undervisningen, som vore allsidigt och bra. Naturligtvis skulle därtill läggas ett antal riksplatser, om jag får använda det uttrycket.

Den linjen hade icke vållat något som helst uppskov, ifall man velat vara med om den, men den hade lämnat erforderligt rådrum. Ett sådant rådrum hade varit önskvärt med avseende å att alla varit överens om att man icke kan taga de nuvarande ritningarna såsom grundval för byggnadsplanen. Alla erkänna, att det enligt dessa ritningar skulle bli på tok för dyrt. Det dröjer i varje fall ett år, till nästa riksdag, innan riksdagen kan fatta positivt beslut beträffande själva byggnadernas struktur. Då menar jag, att man under tiden kunnat från statens sida parallellt med överoch omarbetningen av rit-

ningarna föra förhandlingar med Stockholms stad beträffande vilken tomt man skulle välja och få klart för sig, huruvida ett principavtal skulle kunna träffas i denna punkt, och det skulle då bli och kunna bli klart till nästa riksdag. Jag

an nämna, att det mycket svårare ladugårdsgärdesavtalet icke tog mycket längre tid att göra upp, ehuru det var vida mera omfattande än detta principavtal skulle behöva bli. Nästa riksdag skulle då kunna stå på den linjen, att den haft omarbetade ritningar och en principutredning, huruvida Stockholms stad och kronan skulle gå tillsammans för att skapa ett nytt stort sjukhus.

Men, mina herrar, det ville majoriteten inom statsutskottet icke vara med om. För denna var huvudsaken, att de fingo trehundratusen kronor, så att spaden kunde sättas i jorden på Norrbackaområdet och kronan bindas på den punkten. Man skall aldrig försöka intala dem, som ha någon erfarenhet på området, annat än att med ett bifall till utskottets förslag om anvisande av trehundratusen kronor för planerandet därute är frågan avgjord, icke bara i princip, utan så att det är kronan som kommer att bygga sjukhuset. Det ligger då fullständigt i vida fältet, huruvida ett samarbete skall kunna ske med Stockholms stad under de former och de förutsättningar som föreslagits eller icke.

Således, som sagt, majoriteten i utskottet har tydligen under påverkan av den starka

agitation, som bedrivits, över huvud inte velat resonera om den linje, som går ut på att nu bara träffa ett principavgörande, men att däremot inte sätta spaden i marken genast, då man genom att börja arbetet tydligen velat göra gällande, att även sakfrågan är avgjord.

När jag inte fick understöd för det förslaget inom utskottet, har jag inte fullföljt detta inför riksdagen, därför att det är ju tillräckligt många linjer ändå, det se vi redan under den pågående debatten. Jag skall därför i dag nöja mig med att framföra några allmänna synpunkter beträffande mitt ställningstagande till denna fråga.

Jag har aldrig sett ett sjukhusbyggnadsförslag, som varit så oerhört dyrt som detta. Man skall betänka, att för 843 vårdplatser uppgår byggnadssumman till 24 miljoner kronor, det vill säga kostnaden för varje sjukplats utgör 28,500 kronor. Stockholms stad planerar för närvarande ett stort sjukhus på söder, lika modernt som detta, och för det sjukhuset lär kostnaden ha beräknats till 15,500 kronor per vårdplats. I Norrbackaförslagets 28,500 kronor ingår inte tomten, men i fråga om det nya Stockholmssjukhuset ingår även tomtpriset i detta belopp, 15,500 kronor. Man kan därför säga, att denna kostnad för Norrbackasjukhuset är dubbelt så stor som kostnaden för det modernaste sjukhuset i huvudstaden, ehuru uppfört på annat ställe än detta, skulle beräknas komma att gå till. Det måste vara något fel, när man räknar så. I denna summa ingår givetvis inte heller kostnaden för de teoretiska institutionerna, utan det är endast de anordningar, som krävas för själva sjukvården tillika med utgiften för de relativt begränsade utrymmen, som sammanhänga med undervisningen, som fört till denna kostnad. Jag vädjar till dem av herrarna, som äro eller varit landstingsmän, och som varit med om att skapa moderna sjukhus ute i orterna: Ni veta, att det skulle vara fullständigt otänkbart, att där tala om kostnader, som tillnärmelsevis komme upp mot dessa. Jag är nu inte fackman, och jag kan inte säga, varpå det beror, att Norrbackasjukhuset blir så vanvettigt dyrt, men att det måste vara något fel i fråga om planläggningen eller i något annat avseende synes mig uppenbart.

Men, säger man, utskottet har ju föreslagit, att förslaget skall överarbetas. Jag frågar: tror någon människa, att om riksdagen nu beviljar pengar för att börja arbetet, den kommitté, som sitter och arbetar med frågan, och den arkitekt, som ritat sjukhuset, skola låta tala med sig och gå med på billigare

anordningar annat än i fråga om rena bagateller? Tror man verkligen, att de skulle gå med på att pruta ned kostnaderna något nämnvärt? Ja, då skall man tro, att människorna äro annorlunda konstruerade än de äro! Nej, ha de fått ett principbeslut och arbetet med planeringen satts i gång, så tror jag att det bara blir i fråga om rena bagatellbelopp, som man kan pruta ned kostnaderna. Vi ha för övrigt aldrig gått den vägen här 1 riksdagen, att vi beslutat uppföra en stor institution, utan att veta vad kostnaden blir. Här skulle vi avvika från den regeln. Vi skulle fatta beslut om uppförandet och börjandet av sjukhuset utan att få se, om det över huvud är möjligt att kunna nedbringa kostnaderna.

Sålunda måste jag säga, att första skälet för att jag inte kan vara med om att godkänna det föreliggande förslaget är dess enorma dyrhet. Jag kan inte komma ifrån, att det är ett verkligt slöseri med allmänna medel, om man går in för en sådan byggnadskostnad, som det här är fråga om. Anspråken måste kunna prutas ned här.

Men det stannar inte med detta första byggnadsstadium. Jag har försökt, herr talman, att bilda mig en uppfattning om, var den största. nöden för Karolinska institutet ligger, och jag vågar säga, att sedan Serafimerlasarettet numera blivit ombyggt på sätt som skett, ligger den största nöden för Karolinska institutet inte i de kliniska institutionemas mindre goda beskaffenhet i allmänhet, utan däri att det är så dåligt ordnat i fråga om åtminstone vissa av de teoretiska institutionerna. Man får detta bekräftat, om man har någon anförvant, som studerar på någon av dessa teoretiska institutioner. Om herrarna skulle gå dit och se, under vilka förhållanden berömda och framstående vetenskapsmän arbeta vid Karolinska institutet och hur underhaltiga anordningarna äro vid somliga av de teoretiska institutionerna, skulle ni baxna. För att nämna ett enda exempel — en av mina söner har nyligen gått på den kemiska institutionen — så är det alldeles bedrövligt där. Och skall man taga hänsyn till, att den teoretiska delen av utbildningen och de teoretiska studierna äro för läkarvården och sjukvården av samma stora betydelse, som man också numera tillmäter de praktiskt-medicinska kliniska professorernas undervisning, så måste jag bestämt understryka, att vi inte kunna lämna våra professorer 1 de teoretiska ämnena vid Karolinska institutet att arbeta under så enormt ogynnsamma förhållanden som flera av dem göra. Och jag är så säker på som jag står i denna talarstol, att om riksdagen i dag fattar beslut enligt utskottets hemställan — så kommer inte första spadtaget att ha satts i Norrbacka jord förrän professorerna i de teoretiska ämnena med all rätt och med större saklig styrka än somliga av de kliniska professorerna kunna begära att få sina institutioner mänskligt och ordentligt inredda.

Och det andra skälet, som gör, att jag ställer mig betänksam mot detta förslag, är att, såvitt jag kan bedöma saken, måste det komma att skjuta undan byggandet av de teoretiska institutionerna. De äro inte medtagna i första byggnadsetappen, i 24- miljonersetappen. De kanske äro avsedda att tagas upp i tredje etappen, om 30 år eller så. Vi veta för resten inte, vilka kostnaderna äro för andra eller tredje etappen. Jag har hört en person, som förstår sig på detta, säga, att det stoppar inte med 50 miljoner, om man skall bygga detta sjukhus. Vi hade skisser tillgängliga i statsutskottet, som visade, att inte mindre än 52 byggnader voro inritade i en plan, som skulle representera ett slutligt utbyggande. Men de teoretiska institutionerna skola enligt denna plan lämnas åsido i årtionden framåt och inte kunna komma med. Det blir i sådant fall, som herr Olof Olsson sade, på det sättet, att enhetstanken för långa tider undanskjutes, eller också måste vi bygga för de teoretiska institutionerna samtidigt med att vi bygga för de kliniska institutionerna. Och då är det klart, att det blir mycket svårt för de teoretiska institutionerna att göra

sig gällande. Mer än ett par tre miljoner om året i byggnadskostnader torde det vara svårt att

avse för detta ändamål, och de komma på det sättet att bli ställda åt sidan för de andra.

Hade man gått den andra vägen och sökt få till stånd en överenskommelse med Stockholms stad om gemensamt byggande av detta stora sjukhus, så hade det enligt min övertygelse aldrig behövt bli så dyrt för staten, som det nu blir. Och möjligheten för staten att avsätta en del pengar för att höja det Karolinska institutet jämväl med avseende å dess yttre, höja upp det till den rangplats, som det efter allas vår uppfattning bör ha, den möjligheten hade stått öppen 1 högre grad därigenom, att man fått beräkna en mindre kostnad för byggandet av de kliniska institutionerna.

Mitt andra huvudskäl för motstånd mot det föreliggande förslaget är sålunda, att här skipas genom detta förslag inte rättvisa mot de rent teoretisktvetenskapliga institutionerna för deras anläggningar vid Karolinska institutet, utan de komma att bli skjutna i bakgrunden på ett sätt, som inte är riktigt. Ni skall få se, att det blir på det sättet, att dessa teoretiska institutioner få kämpa en mycket hård och svår kamp i sin strid med de institutioner, som ha direkt sjukvårdande verksamhet.

Jag har den uppfattningen, herr talman, att det vore klokt av riksdagen att inte fatta ett positivt beslut i år. Jag är för min del beredd att taga principen. Jag tror, att vi komma inte ifrån den. Jag tror, att jag var själv såsom medlem av regeringen för några år sedan den förste, som gick in för enhetstanken, och jag tror, att denna tanke har ganska starka och bärande skäl för sig. Jag tror, att de teoretiska professorerna ha rätt i sin uppfattning, att de böra vara knutna vid de kliniska institutionerna med avseende på sin placering. Men skall man komma fram på linjer, som bliva ekonomiskt möjliga för OSS, så att vi verkligen kunna få det igenom, så tror jag, att samarbetslinjen med Stockholms stad är nödvändig att använda sig av, därest denna nybyggnad inte bara skall avse de kliniska institutionerna. Man säger då, att Stockholms stad vill inte detta. Ja, det är ju svårt att avgöra! Men varför frågar maninte Stockholms stad om den saken? Jag har haft många underhandlingar med Stockholms stads förtroendemän, och jag har varit den av statens representanter, som många gånger blivit på allt sätt påpälsad för att jag inte varit till pass för stadens intressen. Men så mycket måste jag säga, att Stockholms stad möter alltid upp med underhandlare, som äro synnerligen kloka och förståndiga människor. De representera ett annat intresse än jag och mina kamrater representera vid underhandlingarna, men de äro klokt och sakligt folk. Jag menar, att samarbetstanken är i och för sig så stark, att om man för stadsfullmäktige lade fram ett förslag med denna tanke som grundprincip — inte lade fram det med armbågen på sätt som den förra kommittén gjorde, då den sade: här är Norrbacka bestämt som förläggningsort för det nya sjukhuset och här ha ni 315 vårdplatser, vill ni taga dem eller vill ni inte? — tror Jag, att utsikter finnas att lösa frågan efter de linjer, som jag skisserat. Men man skall inte förhandla med staden på samma sätt som den kommittén gjorde, om man överhuvud taget skall tänka sig några förhandlingar med Stockholms stad. Man säger nu, att om det blir ett riksdagsbeslut efter de linjer, som jag skisserat i utskottet och som statsutskottets reservanter ha uppdragit, nämligen med tanke på att man bygger ett gemensamt stort

sjukhus för staten och Stockholms stad ute på Norrbacka, så är det inte säkert, att staden accepterar denna tanke. Men jag har vissa skäl att antaga, att Stockholms stad inte skulle betrakta den saken som otänkbar. Se ni, Stockholms stad måste bygga om Sabbatsberg eller måste bygga till Sabbatsberg för en kostnad av omkring 10 miljoner under den närmaste tiden. Stockholms stad går nu efter det avtal, som här föreslås, in i Norrbackaförslaget med 6 eller 7 miljoner kronor.

Stockholms stad står sålunda inför möjligheten att snart få lägga ned 17 miljoner på sina sjukhusbyggnader enbart för de norra stadsdelarna. Skulle det då vara otänkbart, att, då man har med kloka och förståndiga människor att göra, de resonera på det sättet: det kan vara lika bra för Stockholms stad att i stället för att lägga ned 10 miljoner på Sabbatsberg och 7 miljoner på Norrbacka, lägga ned en ungefär lika stor summa som dessa två ensamt på Norrbacka och få Sabbatsberg fritt. Jag kan inte säga, om det är möjligt, men Jag har hittills vid mina försök att komma till tals med ledande personer från Stockholms stad på detta område, aldrig på någon punkt mött något annat uttalande än det: det är klart, att skulle riksdagen gå in för den linjen, så kommer Stockholms stad att med synnerlig omsorg pröva ett sådant uppslag, och den ställer sig icke avvisande till tanken att gå in i förhandlingar om den saken. Det svaret har jag fått på flera olika håll av ledande kommunalmän i Stockholm. Då kan jag inte se, att det i det stora hela skulle ske någon olycka, om man bestämmer sig för ett års uppskov för att undersöka denna sak. Här är ingenting, som egentligen ligger i sjön, annat än de människor, som agitera för en sådan här lösning av frågan. Men på det året kunde man bli i tillfälle att verkligen undersöka saken. Faller förslaget, visar det sig, att Stockholms stad eller kronan inte anser samarbetstanken vara värd att tagas upp, eller visar det sig, att man inte kan komma överens, så har ingenting annat inträffat, än att vi nästa år stå med precis samma möjligheter att fatta beslut som vi i dag ha. Det avtal, som träffats mellan sjukhuskommissionen och Stockholms stad, är nämligen sådant, att det faller inte, om man går reservanternas väg, utan detta avtal är, såvitt jag kan läsa det, bindande för Stockholms stad tills riksdagen formligen avslagit det. Sålunda, den olycka, som skedde, vore ingen annan än att man finge vänta ett år och undersöka den möjlighet, som skulle kunna leda till vad jag skulle vilja kalla för den rationella lösningen av hela sjukhusfrågan.

Jag vet ju inte, om det ligger något i vad en av Karolinska institutets professorer och en Uppsalaprofessor med synnerlig styrka framhållit, eller att det finns viss risk för att rikssjukhuset på Norrbacka inte skulle få ett tillräckligt, allsidigt och omfattande klientel, om man uppehåller både Norrbackasjukhuset och Sabbatsberg. Jag har försökt förhöra mig på andra håll om hur det gått i liknande avseenden. Då jag 1919 tillsatte den första sjukhuskommittén, levde Jag under ganska starkt intryck av de erfarenheter, som gjorts i Köpenhamn, där man uppfört sitt stora Rigshospital efter samma principer som man nu sätter i fråga för detta rikssjukhus. Såsom gammal kommunalman i Malmö och med det livliga utbyte av erfarenheter, som förekom mellan kommunalrepresentanterna i Malmö och i Köpenhamn, kom jag mera ingående att få se Köpenhamns sjukhusanläggningar, och jag måste säga, att den tanke, som man realiserat i Köpenhamn i Rigshospitalet, kanske inte

minst bidrog till, att den första sjukhusutredningen gick på enhetstankens linje. Men jag har nu från flera håll fått bestämda uppgifter om, att Rigshospitalstanken, som var den bärande tanken i Köpenhamn ungefär 1910 och åren närmast därefter, nu slagit slint, och att i och med att den danska landsorten byggt moderna lasarett på samma sätt som vi göra här 1 Sverige, har det klientel, som varit av särskilt värde för undervisningen vid Köpenhamns universitet, till den grad minskats, att köpenhamnarna nu måst gå ifrån tanken på att ha sin läkarundervisning förlagd ensamt vid Rigshospitalet och de ha måst träffa avtal med Köpenhamns kommun om att även få förlägga denna undervisning till stadens sjukhus. Sedan något år tillbaka är den medicinska undervisningen därför förlagd dels till statens Rigshospital och dels till Kommunehospitalet i Köpenhamn. Där har enhetstanken sprängts genom att landsortslasaretten förbättrats, och klientelet som kommer från landsorten till Rigshospitalet, förminskats. Jag har beträf-

fande Lund hört, att sedan Hälsingborg fick sitt stora av landstinget byggda nya lasarett och Kristianstad även fått sitt lasarett utvidgat och man dessutom fått mycket framstående och 1 provinsen utomordentligt betrodda läkare vid dessa, så har det kommit att gestalta sig på det sättet, att medan Lunds lasarett förut upptog flertalet svårare fall från hela Malmöhus och Kristianstads län och långt utanför, har klientelet vid Lunds lasarett undergått samma förändring som jag omnämnde beträffande Köpenhamn. Lunds lasarett har blivit i stort sett ett vanligt länslasarett, och de svåra fallen från respektive områden tagas upp i Hälsingborg och Kristianstad därför att man skapat moderna lasarett där.

Jag kan naturligtvis inte tillmäta försöken att skaffa mig underrättelser från opartiskt folk på detta område någon avgörande betydelse, men klart är, mina herrar, att skulle denna enhetstanke kunna förverkligas på det sättet, att man finge ett kommunalt sjukhus byggt på Norrbacka, som upptager hela det kommunala klientelet här från Stockholms norra stadsdelar, och som därutöver disponerade ett antal riksplatser — 200 eller vilken siffra man vill, det kan bero på ett eventuellt förnyat bedömande av frågan — så har Karolinska institutet åt sig för alla tider säkrat ett klientel, som blir både av ordinär beskaffenhet, och som kommer att inrymma de mera speciella fall, som man behöver tillgodogöra sig för den kliniska och medicinska undervisningen.

Av dessa skäl, herr talman, har jag kommit till den uppfattningen, att man inte borde träffa ett positivt avgörande i år, utan borde ge frågan uppskov. Jag hade, och det vill jag säga allra mest med tanke på den mindre goda behandling som efter min uppfattning de teoretiska institutionerna vid Karolinska institutet blivit utsatta för, för min del helst önskat, att man kunnat gå en mellanlinje, som tillåtit oss att taga ett positivt steg framåt även i år. Men då man från andra håll avvisat den utvägen, nödgas jag, herr talman, ge min röst för reservationen.

3. Ludvig Widell (Första kammarens nationella parti, man)

Herr talman! För att inte förlänga debatten skall jag avstå från att gå in på själva sjukhusfrågan. I den kan jag i allt väsentligt instämma med de talare, som redan fört

utskottsmajoritetens talan. Jag skall heller inte ingå på bemötande av vad de två sista talarna anfört mot utskottets majoritet, då jag förutsätter, att deras argument komma att upptagas till bemötande av mera kompetent person än jag. Jag skall sålunda endast närmare beröra den fråga, som först herr Hammarskjöld tagit upp, nämligen frågan om garnisonssjukhusets inkorporering i det stora kliniska sjukhuset.

Då jag för min del haft att taga ståndpunkt till denna fråga först i armé- förvaltningen, sedan i statsutskottet och nu i dag i riksdagen, har det för mig framstått som den allt övervägande synpunkten, som man måste beakta, att man i varje fall måste garantera de sjuka bland garnisonen samma goda sjukvård, som kommer den civila befolkningen i Stockholm till del. Vi få inte bjuda våra militärer sämre sjukvård än vi bjuda de civila. Från den utgångspunkten har jag för min del inte ett ögonblick tvekat om, att företräde här måste givas åt förslaget att inkorporera garnisonssjukhuset i det stora lasarettet framför att bibehålla ett litet särskilt garnisonssjukhus. Det förefaller mig vara nästan ett axiom, att sjukvården vid ett stort sjukhus alltid måste bli bättre än vid ett litet, detta på grund av de begränsade resurser, det lilla sjukhuset kan utrustas med av ekonomiska och andra skäl. Redan nu är förhållandet vid det nuvarande garnisonssjukhuset det, att man där icke kunnat få en något så när tillfredsställande beläggning av vårdplatserna, utan att man måst i stor utsträckning taga in även civila sjuka. Jag har verkligen svårt att inse, att någon större fördel kan ligga i att man har ett militärt sjukhus med civila sjuka än att man har ett civilt sjukhus med militära sjuka. Från den utgångspunkt, som för mig varit den dominerande, är det självklart, att jag inte kan anse den möjlig-

heten ens vara tänkbar, som herr Holmgren ifrågasatte, nämligen, att man på den militära avdelningen i det stora sjukhuset skulle tillsammans med patienter, som lida av vanliga sjukdomar, även förlägga sådana, som lida av smittsamma sjukdomar. Den möjligheten måste jag anse inte kunna komma i fråga, utan dessa senare måste förläggas för sig. Men jag är övertygad om, att detta låter sig med fördel realiseras även med den organisation av rikssjukhuset, som av Kungl. Maj:t föreslagits och av statsutskottets majoritet tillstyrkts.

Om jag sedan något skulle ingå på de skäl, som anförts mot garnisonssjukhusets inkorporerande i det stora sjukhuset, har herr C. G. Hammarskjöld som första skäl däremot anfört, och däri har herr Holmgren sedermera instämt, att ett sådant beslut skulle komma att föregripa underhandlingarna med Stockholms stad. Statsutskottet har tillstyrkt underhandlingar med Stockholms stad för att undersöka om staden skulle kunna få ett större antal vårdplatser än som i det träffade avtalet förutses. Jag har mycket svårt att förstå, att ett beslut om garnisonssjukhusets inkorporering i det stora kliniska sjukhuset skulle på något sätt kunna skada dessa underhandlingar, ty även med garnisonssjukhusets vårdplatser finns det ändå tillräckligt stort antal platser vid sjukhuset för att bereda Stockholms stad ett betydligt ökat antal platser, därest staden så önskar.

Herr Hammarskjöld anförde vidare, att de militära myndigheterna allmänt avstyrkt detta

förslag, men herr Hammarskjöld omnämnde inte, att den i främsta rummet här ansvariga myndigheten, nämligen generalfältläkaren, på det allra livligaste tillstyrkt förslaget. Det är då uppenbart, att det ur den militära sjukvårdens synpunkt inte kan vara något att anmärka häremot. Herr Hammarskjöld erinrade om det förbehåll, som arméförvaltningen gjort beträffande en del frågor, som arméförvaltningen ansåg böra underkastas närmare undersökning. Ja, men arméförvaltningen har själv sagt, att detta endast bör ske, innan rikssjukhuset tages i bruk, men det är många år till dess, och man har därför rundlig tid att underkasta dessa frågor en närmare undersökning. Arméförvaltningen har inte ansett, att dessa frågor på något sätt skulle hindra att man nu tar ståndpunkt till själva huvudfrågan, nämligen frågan om garnisonssjukhusets inkorporering i det stora sjukhuset. Några andra vägande skäl mot denna åtgärd har jag omöjligen kunnat finna, att herr Hammarskjöld anförde. Herr Holmgren anförde vissa andra skäl. Han ansåg, att det ur Karolinska institutets synpunkt skulle vara olägligt, att man inkorporerar garnisonssjukhuset med det andra. Jag kunde verkligen inte finna, att de skäl, han därvid förebragte, kunna anses på något sätt vägande. Att generalfältläkaren får sitta med i direktionen, och att man har manliga sjuksköterskor i stället för **sjuksköterskor**[3], det är väl inte något, som i och för sig bör hindra en sådan inkorporering.

Då enligt min mening garnisonssjukhusets inkorporering i det stora föreslagna sjukhuset kommer att tillförsäkra garnisonens sjuka den bästa tänkbara vård och en lika god vård som den, som kommer de civila sjuka till del, och då jag inte kan finna, att några olägenheter ur militär synpunkt äro förenade här-

med, anhåller jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag, även